

nao aceita no hiper

MMND56
935210739/04

ROSA OLIVEIRA DA SILVA	
MEDICAMENTOS:	Zopidem
SINTOMAS/QUEIXAS	HAS instável / sonolência
Banheiro	3X
HORA QUE DORME	
HORA QUE ACORDA	
SONECA DURANTE O DIA	IAH = 19,6
HORARIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE:	ALMOÇO: LANCHE: JANTA:
24/03	P = 6,6 IAH = 1,0 m. de uso: 8hr Bem adaptada
22	Qua
24/10	P = 7,0 cmH ₂ O IAH = 1,6 e/ev m. de uso: 7h46'
22	A pressão está estável não vai mais ao banheiro à noite. TROCAR O FILTRO.
31/10	P = 7,0 cmH ₂ O IAH = 1,7 e/ev m. de uso: 7h42'
22	Qua
31/03	P = 7,0 cmH ₂ O IAH = 1,4 e/ev m. de uso: 6h49' Fuga = 8,9 l/min. Bem adaptada
23	Hydroginástica (3x) Pilates (1x) Yoga (1x)
05/07	P = 7 cmH ₂ O m. de uso: 8hr IAH = 1,4 e/ev
23	Mantém hidro e yoga Qua
20/09	P = 7 cmH ₂ O IAH = 1,3 e/ev m. de uso: 8hr
23	Bem adapt. Qua
05/04	P = 7,0 cmH ₂ O IAH = 1,2 m. de uso: 5h42' Fuga = 1,2 lpm.
24	Bem adapt., porém esquece de colocar a máscara. Relata alguns dias de sonolência. Qua.
03/06	P = 7 cmH ₂ O IAH = 1,3 e/ev m. de uso: 6h33' Fuga = 3,6 lpm.
24	Bem adapt.
09/08	P = 7 cmH ₂ O IAH = 1,3 e/ev m. de uso: 6h30'
24	Qua

22/11/24 $P = 7 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,9 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 12'
fuga: 3,6 l/m

Bem adaptada

Natacha

04/02/25 $P = 7 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,8 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 31'
fuga: 5,0 l/m

Bem adaptada
S/ queixas
Natacha

24/04/25 $P = 7 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 26'
fuga: 3,7 l/m

Bem adaptada
Natacha

01/08
25 $P = 7 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,1 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h 26'

Bem adaptado, relata
estar c/ alergia na pele.
Jua.

Nome: ROSA OLIVEIRA DA SILVA
Data de Nascimento: 11-10-1956
IMC: 30,86
Sexo: Feminino
Data do exame: 24-07-2021

Peso: 81 kg
Altura: 1,62 m
Médico: DR. JOSE CASSIO ABREU
Medicamentos:
Histórico:

Lauda de Polissonografia

Exame realizado na noite de 24-07-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 541,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 138,0 e 97,5 minutos. O tempo total de sono foi de 300,5, eficiência de 55,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,2%; estágio N2: 61,9%; estágio N3: 23,8%; sono REM: 11,1%. O índice de despertares foi de 8,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 19,6/hora, sendo elas 35 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 52 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 70%, permanecendo 5,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 51 - 66 bpm e NREM de 50 - 63 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do *Questionário de Sono e escala de Epworth* (0), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem dos estágios N2 e N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 19,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=70%);
5. latência para o sono aumentada;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (7,8/hora);
8. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.